MODELO DE ACUERDO FEDERAL

Acuerdo Federal de Salud: metas de vacunación, equipos de cabecera y crónicos, compra conjunta de medicamentos esenciales y financiamiento nacional por resultados

Acuerdo en el Consejo Federal de Salud por el que la Nación y las jurisdicciones fijan metas públicas de vacunación por departamento, asignan equipos de cabecera sobre el padrón del Programa SUMAR+ con metas de control de crónicos, organizan la compra conjunta del listado completo de medicamentos esenciales del primer nivel, hacen cumplir la prescripción por nombre genérico y vinculan las transferencias nacionales a resultados verificables.

Propuesta 79: Salud: médico de cabecera, hospitales y turnos a tiempo
Cuándo: Fase I (año 1); la firma, en la primera reunión del Consejo Federal de Salud del mandato
Trámite: Se acuerda en el Consejo Federal de Salud (Ley 22.373) y lo firman el Ministerio de Salud y cada jurisdicción. Como compromete transferencias nacionales por resultados, se ratifica por ley nacional (mayoría simple, cámara de origen indistinta) y por la legislatura de cada jurisdicción que lo suscribe, si su derecho lo exige.

CONSIDERANDO:

Que en el presente Acuerdo intervienen el ESTADO NACIONAL, representado por el titular del Ministerio de Salud, y las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lo suscriben, representadas por los titulares de sus carteras de salud, reunidos en el Consejo Federal de Salud creado por la Ley N° 22.373, en adelante 'las partes'.

Que la Ley N° 27.491 declara a las vacunas bien social, establece su gratuidad y obligatoriedad, prevé el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital, cuyo nombre operativo es NOMIVAC (artículo 16), y fija las funciones de la autoridad de aplicación (artículo 18).

Que las coberturas de los refuerzos de la edad escolar están lejos del noventa y cinco por ciento (95 %) que protege a toda la población, y que el problema no es la ley sino su ejecución.

Que las enfermedades crónicas son las principales causas de muerte y se controlan mejor con equipos de cabecera responsables de una población concreta, y que el Programa SUMAR+ ya registra a la población con cobertura pública exclusiva y paga a los centros por prestaciones.

Que el artículo 2° de la Ley N° 25.649 obliga a recetar exclusivamente por nombre genérico, y que la compra conjunta de medicamentos esenciales con precios publicados permite a las jurisdicciones comprar mejor.

Que la salud es competencia concurrente y su ejecución corresponde en gran medida a las jurisdicciones, por lo que el financiamiento nacional debe vincularse a resultados verificables y públicos.

Por ello, LAS PARTES ACUERDAN:

ARTÍCULO 1°.- Cláusula primera – Objeto. Las partes acuerdan metas comunes y públicas de vacunación, de atención primaria con equipos de cabecera y de control de enfermedades crónicas, la compra conjunta de medicamentos esenciales del primer nivel de atención, el cumplimiento de la prescripción por nombre genérico y un régimen de financiamiento nacional vinculado a resultados verificables.

ARTÍCULO 2°.- Cláusula segunda – Metas de vacunación. Las partes fijan como metas: a) noventa y cinco por ciento (95 %) de cobertura en todas las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación en cada departamento del país; b) alcanzar esa cobertura en las primeras dosis dentro de los dos (2) años de la firma; y c) alcanzarla en los refuerzos de los cinco (5) a los once (11) años al cierre de la Fase II del programa de gobierno. Cada jurisdicción incorpora estas metas a su planificación sanitaria.

ARTÍCULO 3°.- Cláusula tercera – Compromisos de la Nación en vacunas. El Ministerio de Salud: a) celebra, dentro de los seis (6) meses de la firma, contratos plurianuales de provisión de vacunas, incluido el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, con stock de seguridad de todo el calendario; b) distribuye las vacunas a las jurisdicciones según un cronograma publicado; y c) envía recordatorios a cada persona o familia, por mensaje al teléfono celular registrado, desde el Registro Nacional de la Población Vacunada Digital previsto en el artículo 16 de la Ley N° 27.491.

ARTÍCULO 4°.- Cláusula cuarta – Compromisos de las jurisdicciones en vacunas. Cada jurisdicción: a) registra en forma nominal cada dosis aplicada en ese Registro, en los sectores público y privado; b) vacuna en las escuelas al inicio de cada ciclo lectivo, en coordinación con su autoridad educativa; c) extiende los horarios de los vacunatorios y realiza búsqueda activa de cada niño, niña o adolescente con el esquema atrasado; y d) realiza operativos casa por casa en los departamentos con cobertura inferior al ochenta por ciento (80 %) en cualquier vacuna.

ARTÍCULO 5°.- Cláusula quinta – Publicación trimestral. El Ministerio de Salud publica cada trimestre, con los datos del Registro, la cobertura por vacuna y por departamento y la lista de los departamentos con cobertura inferior al ochenta por ciento (80 %), sin datos personales.

ARTÍCULO 6°.- Cláusula sexta – Equipos de cabecera. Las jurisdicciones asignan a cada persona inscripta en el padrón del Programa SUMAR+ un centro de salud y un equipo de cabecera responsable de su atención, con turnos por teléfono o por medios digitales. La asignación alcanza a la mayoría de la población con cobertura pública exclusiva al cierre de la Fase II y a su totalidad al cierre de la Fase III del programa de gobierno, conforme el cronograma por jurisdicción que apruebe la Comisión de Seguimiento.

ARTÍCULO 7°.- Cláusula séptima – Control de crónicos. Las partes fijan como meta que el cincuenta por ciento (50 %) de las personas con hipertensión arterial o diabetes asignadas a un equipo de cabecera tenga control registrado al cierre de la Fase II, en el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030 aprobado por la Resolución del Ministerio de Salud N° 1445/2026. El Ministerio de Salud amplía las prestaciones pagadas por el Programa SUMAR+ para remunerar a los centros por el control efectivo de esas enfermedades.

ARTÍCULO 8°.- Cláusula octava – Compra conjunta de medicamentos esenciales. Las partes organizan la compra conjunta, entre la Nación y las jurisdicciones que adhieran, del listado completo de medicamentos esenciales del primer nivel de atención que apruebe el Consejo Federal de Salud. La compra se realiza por licitación pública consolidada, con precios unitarios publicados, y cada jurisdicción paga lo que recibe según el procedimiento que fije el convenio de adhesión.

ARTÍCULO 9°.- Cláusula novena – Prescripción por nombre genérico. Las partes hacen cumplir en sus establecimientos y programas el artículo 2° de la Ley N° 25.649, que obliga a recetar exclusivamente por nombre genérico, promueven la receta electrónica con ese formato y publican cada año el porcentaje de recetas que lo cumplen.

ARTÍCULO 10°.- Cláusula décima – Financiamiento por resultados. El Ministerio de Salud transfiere a cada jurisdicción una parte de los fondos de los programas nacionales de vacunación, atención primaria y medicamentos esenciales en función del cumplimiento verificado de las metas de las cláusulas segunda, sexta y séptima. La Comisión de Seguimiento aprueba, dentro de los noventa (90) días de la firma, los indicadores, las fuentes de verificación y la fórmula de distribución, que se publican. Ninguna jurisdicción recibe por este Acuerdo menos que lo que recibía por esos programas en el ejercicio anterior a la firma.

ARTÍCULO 11°.- Cláusula undécima – Fuente de los recursos. En el ejercicio de la firma, los compromisos de la Nación se atienden con la reasignación de los créditos de los programas nacionales de vacunas, atención primaria y medicamentos esenciales del presupuesto vigente. El componente adicional por resultados se activa con la ley de presupuesto del ejercicio siguiente, que debe preverlo. Cada jurisdicción atiende sus compromisos con su propio presupuesto.

ARTÍCULO 12°.- Cláusula duodécima – Comisión de Seguimiento. Créase en el ámbito del Consejo Federal de Salud una Comisión de Seguimiento integrada por el Ministerio de Salud y un representante de cada región sanitaria, que verifica el cumplimiento de las metas, aprueba los informes trimestrales y la liquidación por resultados y publica sus actas.

ARTÍCULO 13°.- Cláusula decimotercera – Vigencia. El presente Acuerdo rige desde su firma en todo lo que no requiera ratificación y, en lo demás, desde su ratificación, y por cuatro (4) años, y se renueva automáticamente por períodos iguales, salvo denuncia de una parte con una anticipación no menor de ciento ochenta (180) días. La denuncia de una jurisdicción no afecta la vigencia del Acuerdo para las demás.

ARTÍCULO 14°.- Cláusula decimocuarta – Adhesión y controversias. Las jurisdicciones que no lo suscriban en la oportunidad de su firma pueden adherir en cualquier momento. Las controversias se resuelven de común acuerdo en el Consejo Federal de Salud y, en su defecto, quedan sometidas a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

ARTÍCULO 15°.- Cláusula decimoquinta – Ratificación. El Poder Ejecutivo nacional remite el presente Acuerdo al Congreso de la Nación para su aprobación por ley, por comprometer créditos de ejercicios futuros mediante la garantía de la cláusula décima y los contratos plurianuales de la cláusula tercera. Cada jurisdicción lo somete a la ratificación de su legislatura cuando así lo exija su Constitución.
